بروتوكول بحث · دكتوراه في الصحة العامة (PH. D.)

تنظيم الاستجابة المشتركة بين القطاعات للاحتياجات الاجتماعية المعقدة والمتزامنة في الرعاية الأولية

تشكيل الشبكات الملائمة لمختلف أنماط المرضى المتكفل بهم

Eric Bernier، LL.M. و M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca erjb-web.github.io
دكتوراه في الصحة العامة · النظم والمنظمات والسياسات الصحية · ESPUM، جامعة مونتريال

بإشراف مشترك من
الدكتورتين Nadia Sourial و Géraldine Layani

01 السياق

في الرعاية الأولية بكندا، 1 من كل 2 من المرضى يبلغ عن حاجة اجتماعية · *Kosowan et al., 2025*

40 %
من الأسر التي تدفع نصف دخلها للسكن: السكن أو الغذاء
ISQ, 2026

19 %
من الأسر في كيبيك تعاني انعدام الأمن الغذائي في 2023 (14 % في 2018)
ISQ, 2026

ثلاثة مفاهيم متمايزة
التزامن يحصى؛ التعقيد يوصف؛ الاستجابة المشتركة بين القطاعات تنظم داخل منطقة.

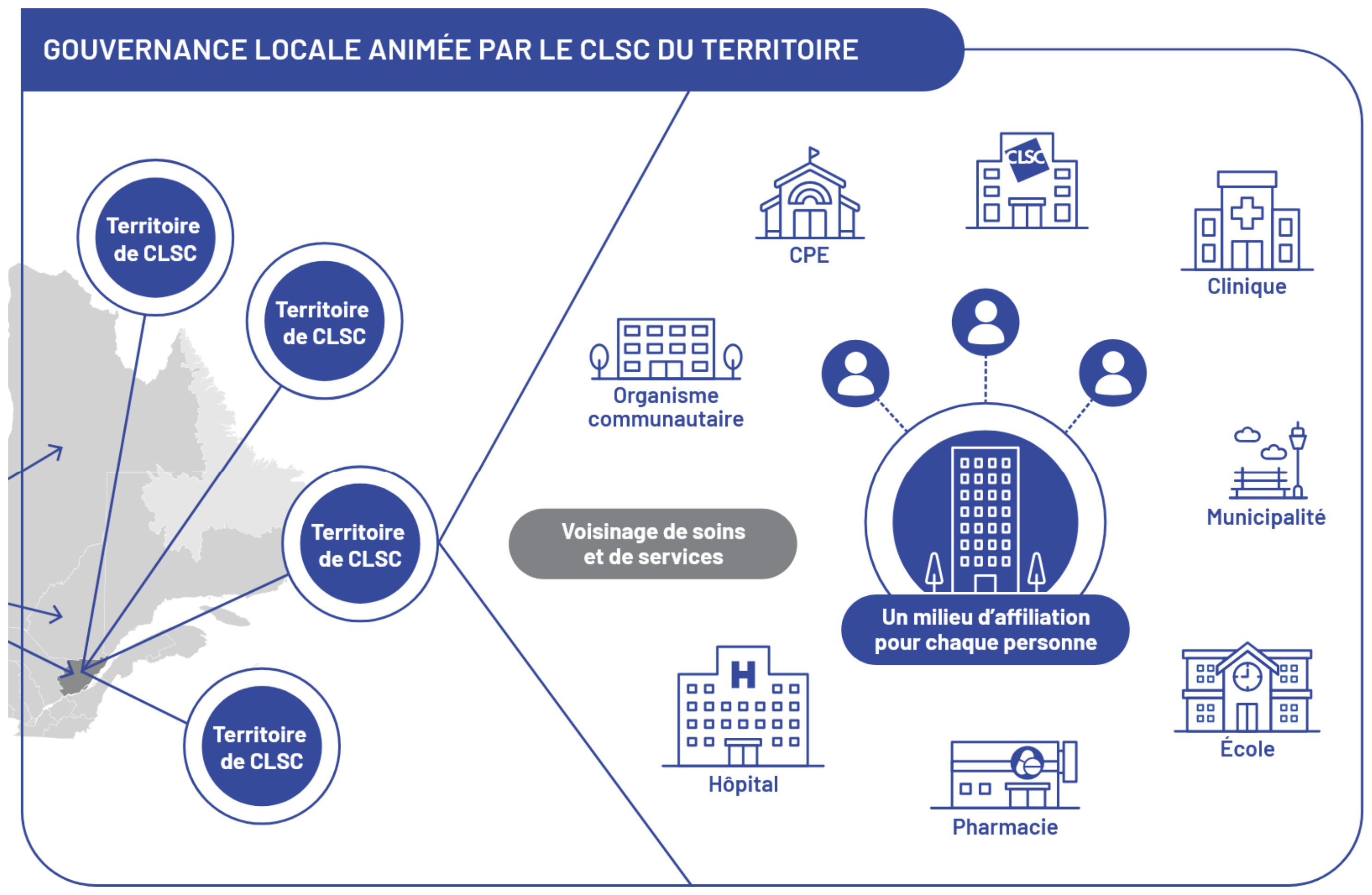
معيار الإدراج
التزامن
حاجتان اجتماعيتان على الأقل في الوقت نفسه.
Kreuter et al., 2021

يوصف، لا يشترط
التعقيد
تراكم الأمراض المزمنة وحالات العجز ومشكلات الصحة النفسية والهشاشة الاجتماعية.
Kuluski et al., 2017

تنظم داخل منطقة
استجابة مشتركة بين القطاعات
إجراءات قطاعات غير قطاع الصحة، تنفذ معه، على الصحة أو محدداتها: CLSC، المستشفى، GMF، الصيدليات، المنظمات المجتمعية، البلدية، المدارس، CPE، القطاع الخاص.
MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013

سياسة الخط الأول · MSSS, 2026

منطقة CLSC تصبح الوحدة المرجعية



أدوار CLSC الأربعة

- ميسّر مشارك
- قائد مشترك بين القطاعات
- منسّق
- موجّه

«بروح من الحوكمة التشاركية» · MSSS, 2026, p. 42 · المخطط: MSSS, 2026

مثال افتراضي · الخيط الناظم

MP

السيدة بروتوكول · 58 عاما

من يستجيب؟ مع من؟ من ينسّق؟

- اكتئاب (السياق السريري)
- ديون
- انعدام الأمن الغذائي
- إنذار بالإخلاء

? الثغرة

على CLSC أن ينسّق. لكن لمجموعة معينة من الاحتياجات، لا شيء يحدد أي الشركاء ينبغي تعبئتهم، ولا كيف يربط بينهم، ولا من ينسّق. **نعرف البرامج المقررة، لا الشبكات المتشكلة فعليا حول مسارات الأشخاص.**

سؤال البحث

كيف تنظم الاستجابة المشتركة بين القطاعات لمختلف أنماط المرضى ذوي الاحتياجات الاجتماعية المعقدة والمتزامنة الذين تتكفل بهم الرعاية الأولية؟

الهدف: ربط كل نمط بـ...

نمط احتياجات → **تشكيلة** من الشركاء → **والجهة** المنسّقة له

02 المنهجية

الميدان: 3 مناطق CLSC متباينة في Lanaudière (حرمان مادي من 7 % إلى 50 % حسب MRC)، إقليم رائد في العمل المشترك بين القطاعات (طاولة مشتركة بين القطاعات) · تصميم متعدد المراحل · O2: SNA بمنهج مختلط تتابعي تفسيري، انطلاقا من CLSC

أي الأنماط؟

01 · التحديد
مراجعة نطاقية
4 إلى 6 حالات وصفية، يصادق عليها 6 إلى 8 فاعلين

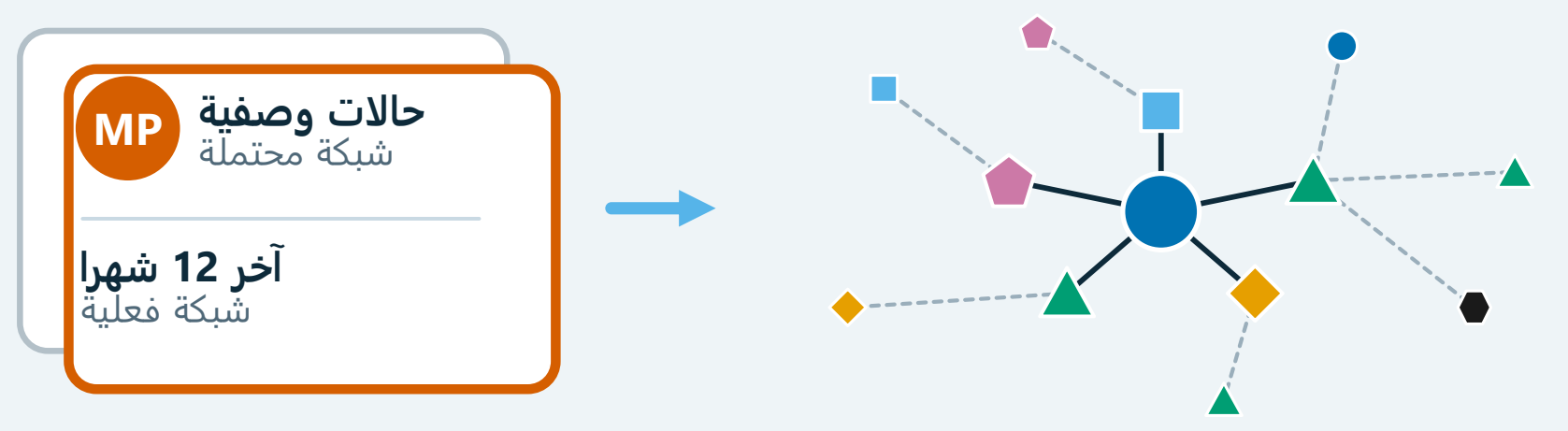
- دراسات منشورة
- أنماط متكررة
- حالات وصفية

← أنماط تحولت إلى حالات وصفية

MP *يرصد نمطها في الدراسات*

من يعبّئ من؟

02 · التحليل
رسم الخريطة انطلاقا من CLSC
3 CLSC، ثم الجهات التي تسميها

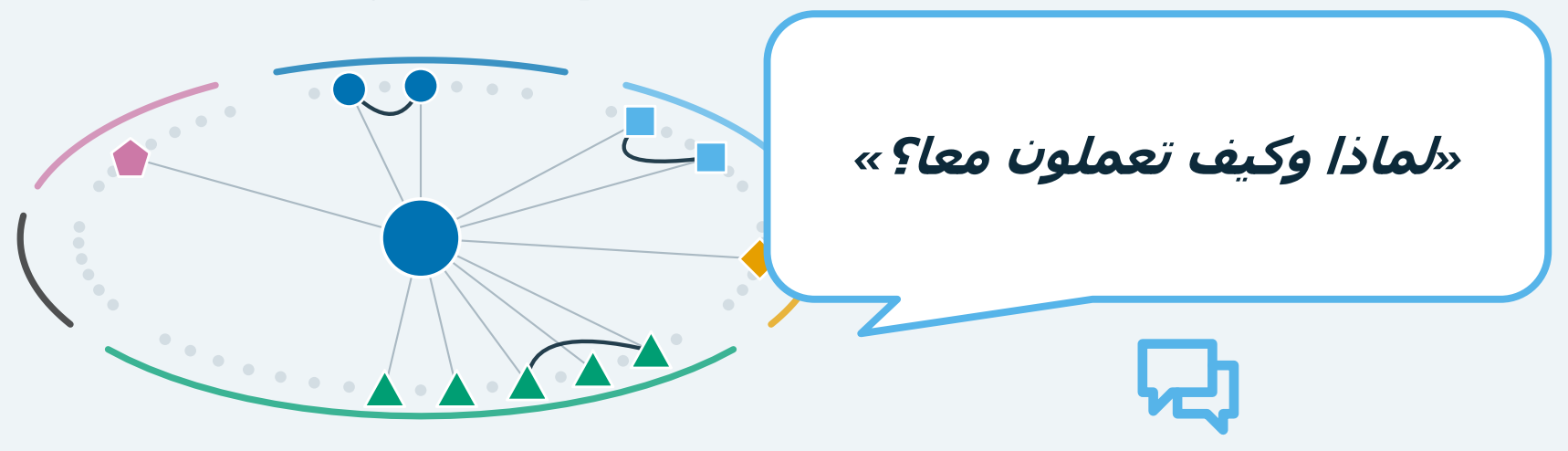


← شبكات محتملة وفعلية

MP *تصبح حالة وصفية*

لماذا وكيف؟

02 · التحليل
SNA نوعي
15–25 مقابلة · 2 إلى 3 مسارات فعلية لكل نمط



«لماذا وكيف تعملون معا؟»

← تفسيرات التفاعلات

MP *يفسر مسارها الفعلي*

بماذا نوصي؟

03 · التوصية
ورشة تداولية
15–20 مشاركا، منهم مرضى شركاء

- ● مرضى شركاء
- ● الرعاية الأولية
- ● المجتمعي
- ● الحوكمة المحلية
- ● البلدي، الخاص

← توصيات لكل نمط

MP *يتداول في ملفها خلال الورشة*

الدمج

32 شهرا · 2026 ← 2029
جدول مشترك لكل نمط

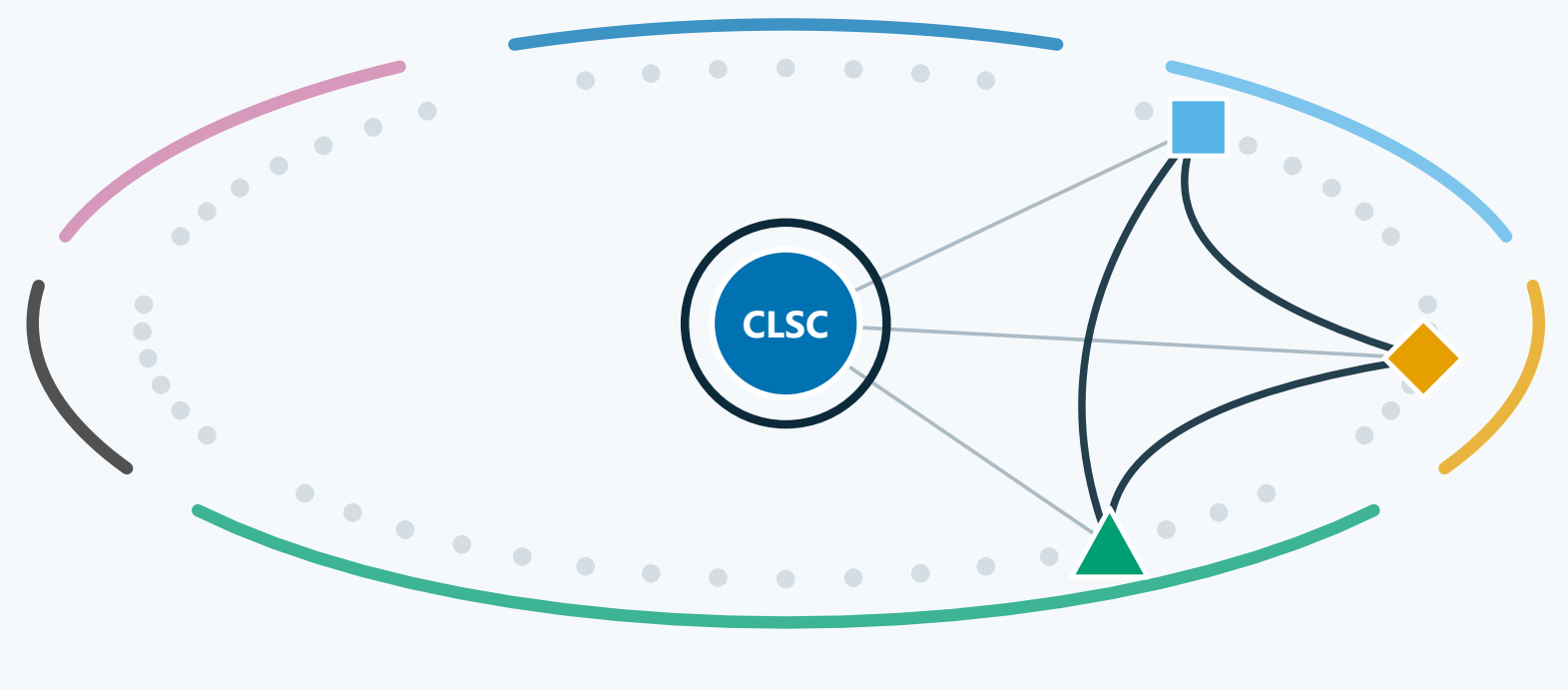
توصيات	لماذا	الشبكة	النمط
			A
			B
			C

MP *معالم مرجعية لنمطها*

03 النتائج المتوقعة

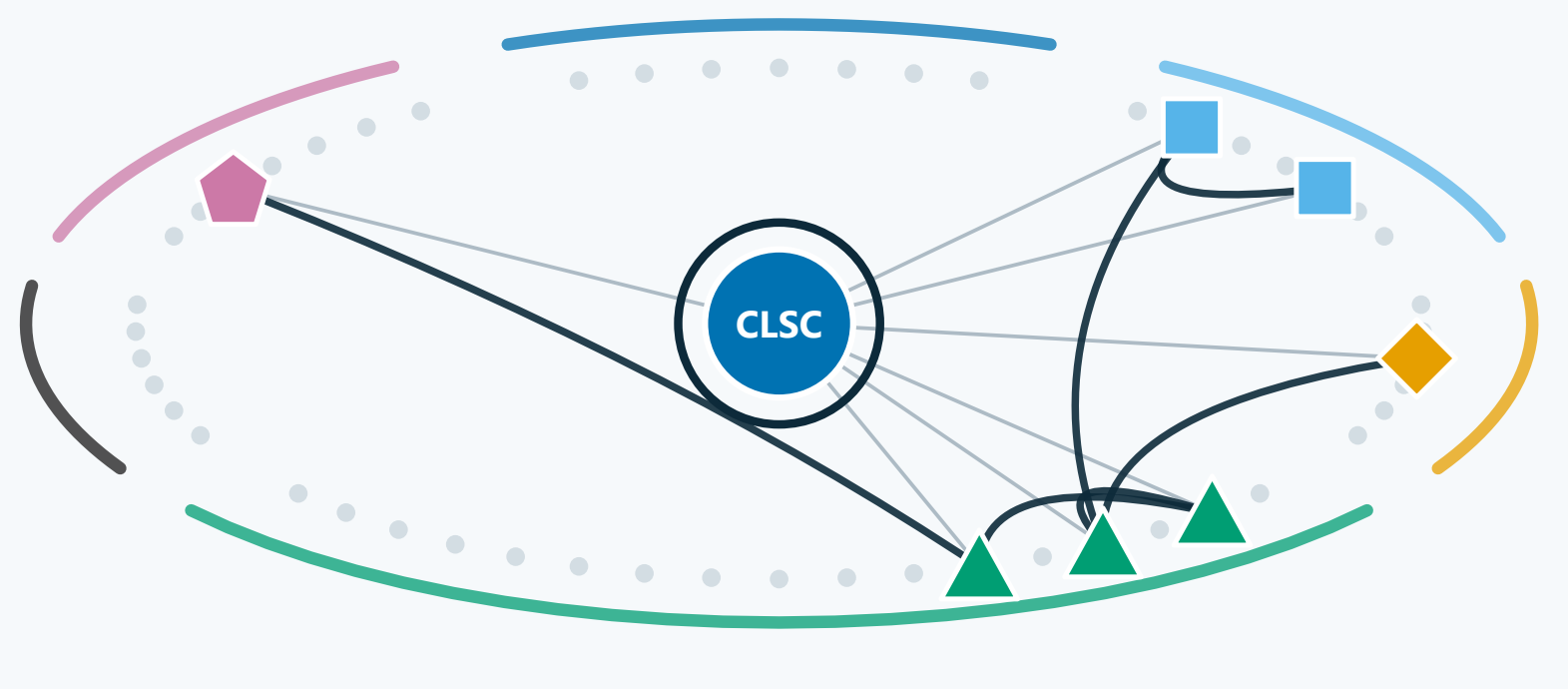
أمثلة افتراضية · **في كل CLSC، تتغير الشبكة المتمركزة حول الأنا بحسب النمط**

A يغلب عليه السكن
إنذار بالإخلاء



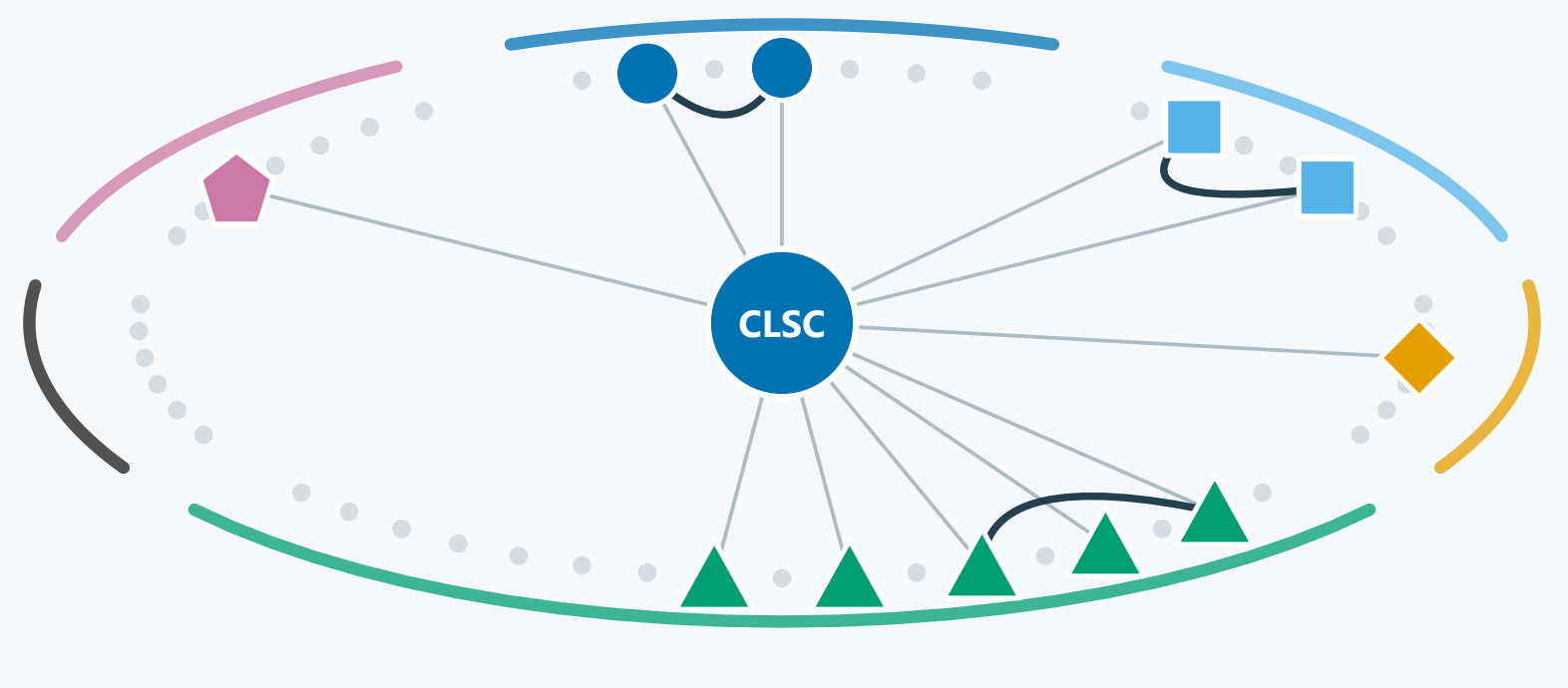
3 شركاء، كلهم مترابطون · CLSC ينسّق

B السيدة بروتوكول
السكن · الغذاء · الديون



7 شركاء، لا يزالون مترابطين · CLSC ينسّق

C تراكم + اكتئاب
الاحتياجات نفسها مع اكتئاب



11 شريكا، قليلو الترابط · بلا منسّق

- ● CLSC (الأنا)
- ◉ منسّق معيّن
- — رابط يصرّح به الشركاء
- • منظمة غير معبّأة
- ● الصحة والخدمات الاجتماعية
- ■ الخط الأول، الصيدليات
- ▲ المجتمعي
- ◆ البلدي
- ⬢ التعليم، الطفولة المبكرة
- ⬟ العمل، العدالة، الخاص

- **H1** **القطاعات تتغير** بحسب النمط ← ***التركيبة بحسب القطاع***
- **H2** **نواة مشتركة،** ومحيط خاص ← ***الشركاء المشتركون***
- **H3** **شركاء أكثر،** لكن أقل ترابطا ← ***الحجم والكثافة***
- **H4** **هل يوجّه CLSC** وينسّق؟ ← ***المنسّق المعيّن***
- **H5** **هل يغيّر النوع الاجتماعي** الاستجابة؟ ← ***نسختان: امرأة، رجل***
- **≠** **فعلية أم محتملة:** ما الفجوة؟ ← ***حالات وصفية مقابل 12 شهرا***

04 الآثار والانعكاسات

لا «شبكة مثالية» تصلح للجميع: معالم مرجعية لكل نمط.

للأشخاص
استجابة مكيّفة مع تركيبة احتياجاتهم

لـ CLSC وشركائه
معالم مرجعية: من نعبّئ، كيف نترابط، من ينسّق

لسياسة الخط الأول
وضع انطلاق مرجعي؛ توصيات وفق أدوار CLSC الأربعة

للبحث
فرضية نمط–شبكة؛ الفجوة بين الشبكات المحتملة والفعلية

النشر: عرض النتائج على المناطق الـ3 · بروتوكول منشور (OSF) · مقالات

جميع النسخ
العربية · 中文 · ES · EN · FR · Innu · ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ضعف البصر · عمى الألوان · صوت · قراءة سهلة

أفكاركم
تعليقات · قراءات · تواصل

مساري
erjb-web.github.io

Colour-blind version: Okabe-Ito colours and one shape per sector

المراجع: CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell و Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017 ; 2026، سياسة الرعاية والخدمات في الخط الأول · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016